

NS			
MARIA SALOMÉ NUNES MIRANDA			
IDADE: 68	PESO: 78	ALTURA: 160	PROFISSÃO: Do lar.
SINTOMAS: Ronco / Insuportação / Acorda de madrugada			
QUEIXAS: Tosse seguida de engasgos / Refluxo.			
MEDICAMENTOS: Tioridaz / Colestirvel / Refluxo / Fibroalgie.			
mov. do mm.F. Dor de cabeça e tontura / Ansiosa			
MÉDICO: Dr. Pedro			
EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates (2x)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 22:30		HORA QUE ACORDA: 00:00	
COCHILO ☒ SIM () NÃO 2h		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO		X NA SEMANA ☒ NÃO	
FUMO () SIM () NÃO		PAROU A QUANTO TEMPO: 46 anos parou	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 2x a 3x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não		MALLAMPATI: IV	
IAH: 46.6%		SPO2: 86%	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Não			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (X) ENDÓCRINA (X) CARDÍACA			
(X) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
Dor lombar / osteoporose colunar / joelhos - fus			
18/08/23 Auda q apneia central - CPAP-90			
4-12cmH ₂ O → IAH = 13.5			
25/08/23 P = 9cmH ₂ O			
IAH = 7.5 e/ev			
M. de uso = 2h23			
másc. esta errada, invertida			
Orientar sobre			
01/09 23 P = 9cmH ₂ O ↓ 8.0cmH ₂ O			
IAH = 16 e/ev			
M. de uso: 6h.			
sem adapt. porém, auda q vazado - fus			
21/09 23 P = 8cmH ₂ O			
IAH = 12.1 e/ev			
M. de uso: 6h40'			
Fuga = 42.4 e/min.			
- ↓ a dor de cabeça.			
- ↓ tontura			
- ↓ tosse e refluxo.			
25/10/23 P = 8cmH ₂ O			
IAH = 15.9 / C: 11 Desc: 0.5 H: 3.2			
Fuga: 33 epm / O: 1.0			
M. uso: 5h30'			
22/11/23 P = 8cmH ₂ O			
IAH = 13.6 / C: 8.3 Desc: 0.3 H: 3.9			
Fuga: 26 / O: 1.0			
M. uso: 5h20'			
refus cefaleia			
e tontura			
↓ P = 7cmH ₂ O.			
↓ umidif. 5			

26/02
24 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 14.6$
m. de uso: 6hs
fuga: 4.2

Trocamos a máscara
e Orientamos elevação
de cabeça
Natacha

20/05/20

03/04/24 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 11.3 \text{ e/h}$
m. de uso: 5h 42m
fuga: 0.1 e/m $P95 = 11.6 \text{ l/m}$

Indice comprar pi anti refluxo
Natacha

05/06/24 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 12.3 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h 30m
fuga: 14.3 e/m (percentil)

Bem adaptada
Natacha

14/08/24 $P = 6.0 \uparrow 6.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 11.8 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h 30'
fuga = 6.0 lpm

fus

30/09/24 $P = 6.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 12.8$ (AC: 7.6 AO: 1.6 Hip: 3.6)
m. uso = 4h 58'
fuga = 11.2 l/min

17/10/24 $P = 6.6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 8.3 \text{ e/h}$ (AC: 5.0 AO: 1.0 Hip: 2.2)
m. uso = 4 horas
fuga = 17 l/min

lenho $P. 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$

Silvia

17/01/25 $P = 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 8.0$
m. de uso: 4h 48'
(Troco o filtro e traqueia)

Exigido uso constante,
inclusive de dia.
Sua claudica

18/03/25 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 13.6 \text{ e/h}$ (AC: 7.7 AO: 1.9 Hip: 3.8)
m. uso = 5 horas
fuga = 8 l/min
* comprou máscara
Pico *

- punhas edmaziadas / queixa cansaço ao esforço
+ bone respir
/ aliento cardio logista
/ meias compressas
/ ↑ cabeça / cominbada

30/05/2025

$$p = 6,0 \text{ cmHg}$$

gente bern; dor me bern

IAH = 8,9 elh (AC: 4,4 AO: 1,4 Hip: 2,8)

time: 5h 38min

peroxy = 4 l/min

Silmi

Nome: MARIA SALOME NUNES MIRANDA

Data de Nascimento: 25-7-1955

IMC: 30,86

Sexo: Feminino

Data do exame: 22-07-2023

Peso: 79 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DR. PEDRO HENRIQUE DE ABREU

MACEDO

Medicamentos:

Histórico:

Lauda de Polissonografia

Exame realizado na noite de 22-07-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 513,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 56,0 e 128,0 minutos. O tempo total de sono foi de 400,0 min, eficiência de 77,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 59,8%; estágio N3: 17,4%; sono REM: 20,1%. O índice de despertares foi de 37,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 46,6/hora, sendo 8 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 110 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 86%, permanecendo 3,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 89 bpm e NREM de 55 - 87 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 46,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (17,1/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

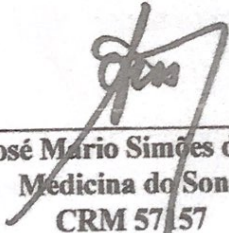
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo

Neurologista

Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia

Neurofisiologia

CRM: 204.363/SP - RQE 79944

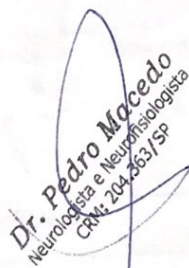
Maria Salomé Nunes Miranda

Rua José Olísio 338 - São José dos Campos

Solicito:

Uso de CPAP ao dormir.

Apneia do sono acentuada.


Dr. Pedro Macedo
Neurologista e Neurofisiologista
CRM 204.363/SP

*Sono Fisio - Dra Ana Claudia.
R. Santa Elza 418
12-3921 1001*



Deixe sua opinião
sobre nossa consulta!

Instagram: @casalneuro_endócrino

